

Ruch + depresja

Efekt antydepresyjny porównywalny z SSRI po 8 tygodniach. Najlepiej działa to, co regularne — nie intensywne.

CZAS: 30 min × 3–5 dni/tyg. 8 tygodni do efektu

ŹRÓDŁO: Schuch i wsp. (2016, metaanaliza); Rebar i wsp. (2015); Cooney i wsp. (2013); Pearce i wsp. (2022)

JAK UŻYWAĆ

Wybierz **jedną aktywność**, którą realnie wykonasz (sekcja 02). Cel: **30 min × 3–5 razy w tygodniu** przez 8 tygodni. Nie musi być intensywna — wystarczy spacer szybkim krokiem. Zacznij od **10 min × 3 dni**, stopniowo zwiększaj (sekcja 03). Prowadź dziennik (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Schuch i wsp. (2016) w metaanalizie 25 RCT (n=1487) wykazali, że ruch ma **duży efekt antydepresyjny** (efekt 1.14) — porównywalny z farmakoterapią i klasycznym CBT. Cooney i wsp. (2013): jako monoterapia ruch działa równie dobrze co leki dla łagodnej i umiarkowanej depresji. Mechanizmy: (1) *BDNF* (czynnik wzrostu nerwów) wzrasta o 30–50 %, (2) *endorfiny* + *endokannabinoidy* zmniejszają ból + poprawiają nastrój, (3) *oś HPA* (reakcja na stres) reguluje się, (4) *sen* poprawia się o 30–40 %, (5) *sprawczość* — pacjent buduje dowód, że coś jest w stanie zrobić. Pearce i wsp. (2022, n>190 000): nawet 1 h ruchu tygodniowo redukuje ryzyko depresji o 18 %. **Najtrudniejsze są pierwsze 2 tyg.** — później mózg zaczyna „pragnąć” ruchu.

01

Pięć mechanizmów antydepresyjnych

1 · BDNF I NEUROPLASTYCZNOŚĆ

Czynnik wzrostu nerwów (ang. *BDNF*) wzrasta o 30–50 %. Hipokamp (zmniejszony w depresji) odrasta. Efekt po 8 tyg.

2 · ENDORFINY I KANNABINOIDY

Naturalne *środki przeciwbólowe* i poprawiające nastrój. „Wysoki na bieganie” — to dosłowne. Po 20–30 min.

3 · REGULACJA OSI HPA

Chroniczny stres w depresji = nadaktywna oś podwzgórze-przysadka-nadnercza. Ruch *obniża* bazalny kortyzol.

4 · SEN

30 min ruchu dziennie = lepsza jakość snu o 30–40 % (Kredlow 2015). Synergiczne z handoutem #24.

5 · SPRAWCZOŚĆ — NAJMOCNIEJSZY MECHANIZM PSYCHOLOGICZNY

Depresja mówi „nic nie potrafisz, nic ci się nie chce”. Każdy zrealizowany trening to *twardy dowód* przeciwny temu. Po 2 tyg. mózg gromadzi 6–10 dowodów — to **materialna zmiana** w przekonaniach kluczowych.

02 Wybór aktywności — co realnie zrobisz?

NAJLEPSZE OPCJE NA START

- ✓ Spacer szybkim krokiem 30 min
- ✓ Pływanie 30 min
- ✓ Joga / pilates 30–45 min
- ✓ Rower 30–45 min
- ✓ Taniec / Zumba 30 min
- ✓ Wchodzenie po schodach 15 min × 2

Wszystkie z tej listy mają porównywalny efekt antydepresyjny w badaniach.

TRZY ZASADY DOBREGO WYBORU

1. Coś, co *lubisz* lub *cierpisz najmniej*. Nie najmodniejsze, nie najefektywniejsze.
2. Coś dostępnego: *nie wymaga* dojazdu >15 min ani specjalnego sprzętu >100 zł.
3. Coś, co możesz zrobić *nawet gdy nie masz energii*: 10 min spaceru w piżamie jest lepsze niż „wymarzony” trening, którego nie zrobisz.

MOJA AKTYWNOŚĆ

— jedna, konkretna

KIEDY, GDZIE, Z KIM

— konkretny plan

03 Plan progresji — 8 tygodni

TYG. 1–2 · START

10 min × 3 dni

Tylko ruszanie się. Cel: *nawyk*, nie wydolność.

TYG. 3–4 · ROZBIEG

20 min × 3–4 dni

Pojawiają się pierwsze efekty psychologiczne (sprawczość).

TYG. 5–6 ·

STABILIZACJA

30 min × 4 dni

Efekt antydepresyjny widoczny. Ciało zaczyna „pragnąć” ruchu.

TYG. 7–8 · UTRZYMANIE

30 min × 4–5 dni

Pełny efekt. Cel: utrzymać poziom *na* zawsze.

04 Dziennik ruchu — pierwsze 4 tygodnie

TYDZ. + DZ.	PN	WT	ŚR	CZ	PT	SB	ND	CO ZAUWAŻYŁEM/-AM?	NASTRÓJ TEN TYDZIEŃ 0–10
Tyg. 1									
Tyg. 2									
Tyg. 3									
Tyg. 4									

Częsta trudność: „nie mam siły / motywacji”. To *oczywiste* — masz depresję, jej cechą jest brak energii. Ale ruch **nie wymaga motywacji**, wymaga *decyzji*. Najpierw decyzja → wstawanie → robienie → energia pojawia się *w trakcie*. Każda osoba w depresji, która spróbowała, raportuje to samo: 5 min przed treningiem „nie chcę”, 5 min po treningu „cieszę się, że to zrobiłem/-am”. To *nie* kwestia silnej woli — to mechanika biologiczna. Po 2 tyg. mózg *zaczyna pragnąć* ruchu (Schuch 2016).